



VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica in Italia

Costruiamo il primo operatore nazionale convertendo centri estetici in cliniche: aggiungiamo la medicina estetica su footfall e clientela già esistenti, industrializzata da un playbook di autorizzazioni e da medici condivisi. Sopra, un dataset clinico proprietario che nel tempo industrializza la qualità e riduce la dipendenza dal medico.

L'OPPORTUNITÀ

Un mercato grande e frammentato, con la finestra ancora aperta

800k+

procedure l'anno in Italia
(500k non chirurgiche,
300k interventi)

90%+

studi indipendenti e mono-
medico: nessuna catena
domina

0

operatori che
medicalizzano i centri
estetici: il fronte che
apriamo noi (le cliniche
sono già contese da 5+
fondi)

36k

centri estetici: l'universo
che medicalizziamo, ben
oltre le poche cliniche
mediche in vendita

L'Europa è già partita

UK: sk:n e Harley Medical aggregate. Il
capitale istituzionale arriverà anche in
Italia: chi costruisce prima detta i prezzi.

Vento GLP-1

I farmaci per la perdita di peso creano
domanda ricorrente: rimodellamento e
skin quality post-dimagrimento.

Ricambio generazionale

Titolari verso la pensione senza
successori: venditori motivati, aperti a
earn-out e permanenza clinica.

È la fotografia del dentale e delle farmacie italiane prima del consolidamento. Il nostro ingresso è la coda lunga dei centri estetici (a sconto) da medicalizzare: ogni trimestre di attesa alza i multipli.

PERCHÉ ORA, E PERCHÉ IN ITALIA

Cinque forze convergono su questa finestra. Non dureranno.

Corsa sulle cliniche, fronte beauty aperto

Le cliniche le consolidano già più fondi (Klinicy verso 60 sedi, Vitaura, Verlinvest, Red Circle). Il fronte dei centri estetici da medicalizzare è ancora libero, ma non per sempre.

Ondata di venditori adesso

Ricambio generazionale: titolari verso la pensione senza successori, aperti a earn-out e rollover. Vendono ora.

Domanda in accelerazione

L'onda GLP-1 crea domanda ricorrente (skin quality e rimodellamento post-dimagrimento) proprio in questi anni.

L'Europa ha dato il segnale

UK e Spagna già consolidate: il capitale arriverà anche qui. Chi costruisce prima diventa la piattaforma da comprare.

L'AI è matura adesso

Per la prima volta agenti e modelli reggono operations multi-sede e decision-support. Chi parte oggi AI-native accumula il dataset.

Il punto sul timing: queste forze non aspettano. Ogni trimestre di attesa **alza i multipli d'acquisto**, riduce i venditori disponibili e, poiché **i dati compongono**, regala a un altro il vantaggio informativo che non si recupera. Il primo che parte non compra solo cliniche: compra il tempo.

Il modello ha già vinto: USA medspa, dentale e farmacie italiane

USA · Medspa: la scala paga

- ◆ Studio mono-medico 3-6x EBITDA; piattaforma recurring 30%+ a 7-12x
- ◆ I membri valgono 4,8x il lifetime value e spendono +35% a visita
- ◆ 2026 anno record M&A: LaserAway in vendita >2 mld \$

Italia · Sanità-retail: già eseguito qui

- ◆ Stessa struttura: mono-professionista, contabilità artigianali, zero brand
- ◆ Dentale (DentalPro) e farmacie (Hippocrates): da studi grigi a catene nazionali via PE
- ◆ Vince M&A disciplinato + trasformazione operativa, non la tecnologia

La medicina estetica ha 3 vantaggi strutturali: 100% pay-per-service senza convenzioni, ricorrenza naturale 3-4 visite/anno, margini lordi superiori sugli iniettabili.

Due motori: arbitraggio dei multipli e trasformazione del formato



Compriamo **asset che generano già cassa** (centri estetici a sconto, cliniche in successione) e li **medicalizziamo** con un format replicabile e due macchine: **playbook autorizzazioni** e **medici condivisi**. Anche senza espansione dei multipli, la crescita dell'EBITDA e la scala generano ritorno: **l'arbitraggio è il moltiplicatore, non la scommessa.**

Perché è fattibile e veloce: convertiamo centri estetici in cliniche

Non partiamo dalle poche cliniche mediche in vendita (scarse, care, contese). Partiamo dai **centri estetici**: universo enorme, economico, con clientela e footfall già attivi, e ci **aggiungiamo la medicina estetica**. Due playbook industrializzati tolgono i colli di bottiglia che fermano tutti gli altri.

1 • Playbook autorizzazioni

L'autorizzazione sanitaria è lo step lento: lo industrializziamo. Filtro di convertibilità pre-deal, template di sede medica, partner regolatorio, relazioni con ATS/Comune. **Da mesi bespoke a settimane ripetibili.**

2 • Medici condivisi

Un **pool di medici che ruota part-time** su più sedi (come già fa il nostro CMO): medicalizzi molte sedi con pochi medici, ogni sede subito profittevole (niente medico full-time).

3 • La fiducia è già del centro

Il cliente è fedele **all'insegna, non a un medico**. Medicalizzando ereditiamo quella fiducia e una base clienti già calda: il paziente resta legato **a noi, non al singolo medico**. La dipendenza dal medico (rischio n°1) è disinnescata all'origine.

Il roll-up rotola davvero. Il centro estetico paga l'affitto col non-medico mentre medicalizzi; il medico condiviso aggiunge margine alto a costo fisso basso; il playbook autorizzazioni replica sede dopo sede. Ogni conversione è un'unità piccola, economica, veloce e ripetibile: dove Klinicy e Faceland comprano cliniche mediche care e un medico per sede, noi convertiamo sedi economiche con medici condivisi.

Sei caratteristiche: cosa applichiamo a ogni sede (clinica o centro medicalizzato)

Recurring su prescrizione

Percorsi programmati a pagamento mensile + membership. Target 15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi, 30% a regime.

Multi-provider by design

2+ medici e protocolli condivisi: il paziente è fedele al brand e al percorso, non al singolo.

Mix clinico completo

Iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1: più categorie e più visite per paziente.

Patient journey da retail

Beauty advisor, consulenza strutturata, follow-up e recall automatici: esperienza premium.

Pagamenti rateali

Rateizzazione a tasso zero: alza il ticket e apre la fascia 25-40, già abituata al buy-now-pay-later.

Gestione manageriale

GM di area, KPI settimanali (saturazione, conversione, retention), procurement e marketing centrali.

Ogni elemento è già validato nel mercato USA; l'insieme non esiste ancora in nessuna clinica italiana.

La formalizzazione è il motore del valore, non un costo

Il settore è frammentato, a pagamento e in gran parte informale: **è proprio questo a deprimere i multipli d'ingresso**. Chi porta trasparenza cattura il re-rating, come nel dentale/diagnostica in Brasile e India (da studi grigi a piattaforme premium).

Rate = tracciabilità

Il pagamento mensile su carta/finanziaria rende il ricavo bianco e allarga il mercato. Formalizzi crescendo.

Rollover in equity

Il titolare (del centro estetico o della clinica) reinveste parte del prezzo in una quota della piattaforma: trasforma reddito personale in capitale tassato e si allinea all'exit di gruppo.

Compliance = multiplo

Un asset pulito e bancabile vale 7-10x; gli studi grigi 3-4x. La regolarizzazione è l'espansione del multiplo, ed è il moat.

L'AI non è una promessa a 10 anni: crea valore su tre orizzonti

OGGI · MARGINE

Operations AI-native

Agenti gestiscono agende, recall, pricing, procurement e KPI. **HQ snello, integrazione più rapida, margini migliori da subito**: il vantaggio operativo che uno studio da solo non ha.

MEDIO · QUALITÀ

AI decision-support

Sul dataset reale del gruppo l'AI suggerisce piano e dosaggio, standardizza la qualità e **riduce la dipendenza dal singolo medico** (il rischio n°1). Il medico decide.

LUNGO · COSTO

Automazione

Il dataset di outcome è il substrato per **l'automazione delle procedure standardizzate**: attacca il costo e il collo di bottiglia dell'ora-medico.

Azienda AI-driven end-to-end (modello Bending Spoons). Lo stesso layer AI che fa girare le sedi guida la **macchina di M&A**: origination e scoring dei target, filtro di convertibilità autorizzativa, due diligence e integrazione a 100 giorni. Il dataset proprietario di outcome è ciò che la finanza da sola non compra: sposta la valutazione verso un multiplo AI-platform ed è il moat che rende il roll-up di questo team difendibile.

La clinica resta medica, la piattaforma fa il resto

Area clinica (per sede)

Direttore sanitario e autorizzazione per struttura; medici condivisi tra sedi; area estetica non-medica separata dall'atto medico; piena autonomia clinica.

Piattaforma di gruppo

M&A e finanza; brand, marketing, percorsi; procurement centralizzato; GM di area, HR, software e KPI.

Comitato scientifico

Indipendente, sopra il CMO: protocolli e audit.

Incentivi $\neq$ volumi

Mai bonus sul venduto: sicurezza e retention.

Audit & mystery patient

Controlli periodici per sede e consulenza.

Soglie reputazionali

KPI con blocco espansione al bisogno.

Cosa compriamo, a quanto, e come strutturiamo

Due tipi di target

- ◆ **Centri estetici** da medicalizzare: footfall, clientela fedele, sede convertibile
- ◆ **Cliniche** avviate: ricavi 0,8-2,5M, EBITDA 20%+, iniettabili prevalenti
- ◆ Sede **convertibile ad ambulatorio** (destinazione d'uso, requisiti): filtro pre-deal
- ◆ Bacino 100k+ ab.; cluster (Milano first, poi NO/NE)
- ◆ Titolare disponibile a permanenza + rollover

Struttura tipo

- ◆ Prezzo 3-4x EBITDA normalizzato
- ◆ 60-70% cash al closing
- ◆ 15-20% earn-out su risultati a 24 mesi
- ◆ 15-25% rollover equity nella piattaforma
- ◆ Non-compete e patti di permanenza

Pipeline proprietaria

Origination dal network clinico, congressi, fornitori di iniettabili/dispositivi (che conoscono i volumi reali) e advisor di consolidamenti sanitari italiani. Il deal flow migliore non passa dai broker.

ROADMAP

Dal format lab al primo operatore nazionale

FASE 1 · MESI 0-18

Provare la conversione

Format lab + prime conversioni (centri estetici medicalizzati) a Milano. Prova playbook autorizzazioni e tasso di conversione. Avvio raccolta dati.

conversione provata, EBITDA/sede +30%

FASE 2 · MESI 18-36

Densità regionale

8-12 cliniche in 2-3 cluster. Playbook 100 giorni, procurement pieno, brand, leva bancaria.

10+ sedi, recurring 20%+, EBITDA 4-6M

FASE 3 · MESI 36-60+

Scala nazionale ed exit

20-30 cliniche + dataset maturo. Target dei consolidatori PE / device-maker.

exit 7-10x, upside med-tech

Il data play matura come layer trasversale: da moat di qualità (Fase 1) a decision-support (Fase 2-3) a opzione di automazione (oltre).

L'economia di una conversione: centro estetico medicalizzato

Centro estetico	All'acquisto	Medicalizzato (24 mesi)
Ricavi	0,60M	1,00M
Margine EBITDA	15%	28%
EBITDA	90k	280k

Numeri illustrativi da benchmark, da validare in DD.

+ Medicina estetica

Medico condiviso part-time sulla base clienti esistente: injectables ed energy-based ad alto margine.

Comprato ~3x (270k)

+ capex conversione ~150-300k (autorizzazione, sale, device). Il non-medico paga l'affitto durante la conversione.

Ritorno

280k EBITDA a regime; a multiplo medico 8x vale ~2,2M: doppio arbitraggio (sconto + re-rating).

Il consolidamento delle cliniche è affollato: il fronte dei centri estetici no

	Cosa consolidano	Backer	Beauty → medico	Dato + AI
Klinicy	Cliniche estetiche (verso 60 sedi entro il 2028)	Investitori	No	No
Vitaura	Cliniche estetiche e longevity	LIAN Group (LU)	No	No
Faceland · Juneco	Cliniche medico-estetiche	Verlinvest (BE)	No	No
Villa Brasini	Clinica estetica premium	Red Circle (R. Rosso)	No	No
Franchising (He Mediclinic, SkinMedic)	Poliambulatori in affiliazione	Parziale (non convertono)	No	No
VENERE	Centri estetici da medicalizzare	Family office + debito	Sì · cuore	Sì · moat

Il consolidamento delle cliniche è reale e già competitivo (cliniche scarse, multipli in salita: Klinicy, Vitaura, Verlinvest, Red Circle). Venere apre il **fronte inesplorato**: acquisire e medicalizzare i centri estetici (36k, economici) con medici condivisi, finanziamenti a medio termine e un network di medici. Non è solo un business, è un movimento.

IL TEAM

Visione, AI, clinica, operations: competenze complementari



Luca Martino

FOUNDER & CEO

Imprenditore tech, fondatore e CEO di un gruppo AI enterprise in fase di exit. Visione, capitale, M&A, investitori.



Salvatore Diana

CHIEF AI OFFICER

Architetto della piattaforma agentica e del dataset proprietario: outcome tracking, AI decision-support e la roadmap verso l'automazione. Il moat che la finanza non compra.



Marcello Cammalleri

CHIEF MEDICAL OFFICER

Medico chirurgo estetico: protocolli, format clinico, reclutamento medici e deal flow. Sotto il comitato scientifico indipendente.



COO

COO
OPERATIONS · TBH (TO BE HIRED)

Reti multi-sede in sanità e consumer premium. Format e P&L per sede, patient journey, integrazione a 100 giorni.

Contrappesi per costruzione: CFO espresso dagli anchor investor; deal team M&A; comitato scientifico indipendente sopra il CMO; consigliere indipendente in board; advisor regolatorio-sanitario, fiscale-M&A e da consolidamenti sanitari italiani già eseguiti.

L'ORIZZONTE

Un asset che l'AI non erode ma potenzia, con un secondo atto oltre i 10 anni

Non-disruptabile

L'atto medico è fisico, autorizzato, locale. L'AI qui è un tailwind operativo, non una minaccia sul ricavo.

Runway 5-10 anni

Più consolidi, più il multiplo si espande e più diventi il #1 nazionale: la scala lavora a favore.

Oltre: automazione

Il dataset apre la strada all'automazione delle procedure standardizzate: da servizi a med-tech.

VENERE · Riservato e confidenziale

Cosa può andare storto, e come l'abbiamo progettato

Dipendenza dal medico

Multi-provider obbligatorio, rollover ed earn-out sulla permanenza, fedeltà al brand e al percorso.

Regolatorio e deontologico

Struttura MSO, comitato scientifico, comunicazione conforme, advisor regolatorio dal giorno uno.

Autorizzazioni sanitarie

Filtro di convertibilità pre-deal (destinazione d'uso, requisiti) + playbook autorizzazioni + advisor regolatorio: compriamo solo sedi convertibili.

Conversione beauty → medico

Tasso di conversione provato su 1-2 sedi prima di scalare; il ricavo non-medico copre i costi durante la medicalizzazione.

Esecuzione M&A

Playbook 100 giorni nel software, Fase 1 piccola per raffinare il metodo prima di scalare.

Consolidatori concorrenti

Campo affollato sulle cliniche (Klinicy, Vitaura, Verlinvest). La difesa: un fronte diverso (centri estetici) + velocità + moat dati. Chi ha già cluster diventa la piattaforma da comprare.

Il rischio n°1 resta reputazione e qualità clinica: per questo un intero sistema di governance clinica con soglie di blocco.

Due raccolte in sequenza: prima proviamo, poi scaliamo

OGGI · L'ASK

€500k

Seed per provare il modello

Compriamo e medicalizziamo **3 dei primi 5 centri estetici**, con Marcello direttore sanitario. Proviamo tasso di conversione, autorizzazioni ed EBITDA per sede. Check piccolo, rischio basso.

A MODELLO PROVATO

€2,5-4,5M

Round di scala

Replica massiva in Italia con il playbook: autorizzazioni + medici condivisi + macchina AI. Leva bancaria a supporto.

Struttura: club deal di family office con governance attiva (board seat e CFO dagli anchor), tranche legate a milestone. Orizzonte 5-6 anni, exit a PE/strategico, target 7-10x EBITDA e MOIC 2,5-3,5x, con upside dal dataset. **Ti chiediamo ora il seed da €500k**, con prelazione sul round di scala.



VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica, e la piattaforma di dati che lo rende difendibile nel tempo.

Convertiamo centri estetici in cliniche aggiungendo la medicina estetica, con un playbook di autorizzazioni e medici condivisi; formalizziamo un settore grigio e costruiamo il dataset che industrializza la qualità. Un mercato grande e frammentato, con la finestra ancora aperta.